

Handicap, autonomie et travail social

**Du protégé au sujet de droits — Transformations du champ du handicap et
nouvelle posture du travail social**

Pierre Brasseur

05 juin 2026

Cet ouvrage rassemble le matériel pédagogique d'un module Bachelor en travail social consacré aux transformations contemporaines du champ du handicap. Il propose une systématisation des quatre modèles théoriques (médical-réadaptatif, social, MDH-PPH, droits + capacités), une analyse des transformations du champ (désinstitutionnalisation, autodétermination, financement orienté personne), et une lecture des effets sur la posture professionnelle à travers trois tensions structurelles. Il est ancré dans le cadre suisse et genevois.

Table des matières

Bienvenue	6
Architecture du livre	6
Une intuition pédagogique	6
Liens	6
Comment citer	7
Licence	7
 I Préliminaires	 8
1 Positionnement	9
1.1 Identité du module	9
1.2 Articulation dans le PEC20	9
1.3 Architecture des 13 séances	9
1.4 Co-animations	10
1.5 Objectifs d'apprentissage de la séance 4	10
1.6 Note méthodologique	10
2 La vignette de Léa	12
2.1 Une vignette comme dispositif	12
2.2 Trois personnages, trois positions	13
2.3 Trois questions à garder en tête	13
2.4 Une éthique de la vignette	14
 II Quatre modèles du handicap	 15
3 Modèle médical et réadaptatif	16
3.1 Genèse historique	16
3.2 Logique opérationnelle	16
3.3 Posture professionnelle qu'il appelle	16
3.4 Limites et critiques	16
3.5 Persistance contemporaine	17
4 Modèle social (Oliver, UPIAS 1976)	18
4.1 La rupture conceptuelle	18
4.2 Conséquences théoriques	18
4.3 Posture professionnelle qu'il appelle	18
4.4 Critiques formulées depuis l'intérieur	18
4.5 Apport durable	19
5 Modèle MDH-PPH (Fougeyrollas)	20
5.1 Origine et diffusion	20
5.2 La métaphore du funambule	21
5.3 Posture professionnelle qu'il appelle	21
5.4 Diffusion en Suisse romande	21
5.5 Limite opérationnelle	21

6	Modèle droits + capacités	22
6.1	Pilier juridique : la CDPH ONU 2006	22
6.2	Pilier philosophique : l'approche par les capacités	22
6.3	Posture professionnelle qu'il appelle	23
6.4	Retour à Léa	23
6.5	Limite	23
III	Transformations contemporaines	24
7	Désinstitutionnalisation	25
7.1	Cadre normatif	25
7.2	Mobilisation politique suisse	25
7.3	Précisions critiques	26
7.4	Pour le travail social	26
8	Autodétermination, agentivité, pair-aidance	28
8.1	Théorie de l'autodétermination	28
8.2	Le modèle fonctionnel de Wehmeyer	28
8.3	L'enjeu opérationnel	28
8.4	Savoirs expérientiels et pair-aidance	29
8.5	Vigilance épistémique	29
9	Financement orienté personne	30
9.1	La contribution d'assistance AI	30
9.2	Critiques structurelles	30
9.3	Mise en perspective comparée	30
9.4	Retour à Léa	31
IV	Posture professionnelle	32
10	Tension protection / autonomie	33
10.1	La dignité du risque (Perske 1972)	33
10.2	Le déplacement juridique (CDPH art. 12)	33
10.3	L'éthique du care comme cadre théorique	33
10.4	Implications pour le travail social	34
11	Tension expertise / savoir expérientiel	35
11.1	La formule fondatrice	35
11.2	Transformations institutionnelles	35
11.3	Vigilance épistémique	35
11.4	Conditions opérationnelles	36
11.5	Pour le travail social	37
12	Tension travail prescrit / travail réel	38
12.1	La clinique de l'activité	38
12.2	La <i>street-level bureaucracy</i>	38
12.3	Les marges du métier	39
12.4	Le travail émotionnel	39
12.5	Le praticien réflexif	39
12.6	Synthèse opérationnelle	39

V	Application	40
13	Activité et synthèse	41
13.1	Consigne de l'activité (5 minutes)	41
13.2	Posture du formateur	41
13.3	Trois acquis à retenir	42
13.4	Ouverture sur la séance 5	42
13.5	Lectures recommandées	43
14	Auto-évaluation	44
14.1	Exercice 1 — Reconnaître les modèles	44
14.2	Exercice 2 — Distinguer impairment et disability	44
14.3	Exercice 3 — Mobiliser une capacité	45
14.4	Exercice 4 — Identifier la tension	45
14.5	Exercice 5 — Activer un droit vulnérable	46
	Conclusion	47
	Ce que cet ouvrage n'est pas	47
	Travail à venir	47
	Remerciements	48
	Contact	48
	Annexes	49
A	Cadre suisse et genevois	49
A.1	Cadre légal fédéral	49
A.2	Cadre légal genevois	49
A.3	Initiative <i>Pour l'inclusion</i>	49
A.4	Acteurs institutionnels genevois	50
A.5	Projet emblématique : Sureaux	50
A.6	Écosystème de recherche HETS	51
B	Glossaire	52
	Références	54

Bienvenue

Cet ouvrage

Cet ouvrage rassemble le matériel pédagogique du module Bachelor en travail social *Handicap, autonomie et travail social* (HETS Genève, semestre 4). Il a été préparé pour la **leçon probatoire HETS Genève du 5 juin 2026** par **Pierre Brasseur**, candidat au poste de Professeur HES associé à 80 % — réf. 309.

Architecture du livre

L'ouvrage est organisé en six parties, qui suivent la progression de la séance probatoire :

1. **Préliminaires** — positionnement institutionnel et vignette pédagogique fondatrice
2. **Quatre modèles du handicap** — quatre grilles d'analyse en chapitres séparés
3. **Transformations contemporaines** — désinstitutionnalisation, autodétermination, financement orienté personne
4. **Posture professionnelle** — trois tensions structurelles
5. **Application** — activité pédagogique et auto-évaluation
6. **Annexes** — cadre suisse, glossaire, bibliographie complète

Chaque chapitre comporte une **thèse centrale**, des **citations situées**, des **exemples d'application en formation pratique**, et des **limites assumées**.

Une intuition pédagogique

Les modèles du handicap **ne sont pas des étapes successives**. Ils coexistent dans chaque institution comme **grammaires actives**. Reconnaître le modèle dominant d'un dispositif, c'est déjà commencer à y intervenir.

C'est l'intuition qui structure l'ouvrage.

Liens

- **Site web compagnon** : pierrebrasseur.github.io/cours-handicap-ts
- **Carnet de recherche** : pierrebrasseur.github.io/blog-recherche
- **Contact** : pierre.brasseur@hetsge.ch

Comment citer

Citation suggérée

Brasseur, P. (2026). *Handicap, autonomie et travail social. Du protégé au sujet de droits — Transformations du champ du handicap et nouvelle posture du travail social*. Genève : HETS / HES-SO. <https://pierrebrasseur.github.io/handicap-autonomie-ts/>

```
@book{brasseur2026handicap,  
  title = {Handicap, autonomie et travail social. Du protégé au sujet de droits},  
  author = {Brasseur, Pierre},  
  year = {2026},  
  publisher = {HETS Genève / HES-SO},  
  url = {https://pierrebrasseur.github.io/handicap-autonomie-ts/}  
}
```

Licence

Le contenu est mis à disposition sous **Creative Commons BY-NC-SA 4.0**. Citation requise, usage non commercial, partage dans les mêmes conditions.

partie I

Préliminaires

1 Positionnement

i En bref

Module Bachelor TS de spécialisation (5 ECTS, 13 séances), semestre 4. Le présent ouvrage déploie la séance 4 — la **séance probatoire du 5 juin 2026** — et fournit les ressources nécessaires pour la situer dans le module complet.

1.1 Identité du module

Élément	Valeur
Intitulé	Handicap, autonomie et travail social
Niveau	Bachelor en travail social, semestre 4
Crédits ECTS	5
Volume horaire	13 séances de 4h = 52 h présentiel + 78 h travail personnel
Responsable	Pierre Brasseur
Orientations	Éducation sociale (principalement), ouvert aux trois orientations

1.2 Articulation dans le PEC20

Pré-requis (semestre 3) : modules *Politiques sociales suisses* et *Méthodologie d'intervention*.

Préparation à (semestres 5-6) : formation pratique 2 dans des institutions du champ du handicap, et MAP de spécialisation Bachelor.

Compétences PEC20 ciblées : C1, C2, C3, C4, C5, C7, C8, C9, C11.

1.3 Architecture des 13 séances

La séance 4 — celle que développe le présent ouvrage — est la **séance pivot** du module. Les trois séances précédentes posent les jalons théoriques et historiques. Les neuf séances suivantes approfondissent chacun des thèmes esquissés à la séance 4.

Co-animation	Séance
--------------	--------

1.4 Co-animations

Co-animation	Séance
Manon Masse (HETS)	6. Autodétermination
Catherine Lenzi (HETS)	12. Posture professionnelle
Chloé Souesme (HETS)	7. Pair-aidance
Geneviève Piérart (HETS Fribourg)	10. Familles, intersections
Pair-aidant · e (AGILE.CH ou Cap-Contact)	5. Désinstitutionnalisation et 7. Pair-aidance
Professionnel · le (Fondation Ensemble ou EPI)	8. Financement orienté personne

1.5 Objectifs d'apprentissage de la séance 4

À l'issue de cette séance, l'étudiant · e sera capable de :

1. **Identifier** les quatre principaux modèles théoriques du handicap et **reconnaître** leurs effets sur la pratique professionnelle [C1, C7]
2. **Mettre en relation** les transformations contemporaines (désinstitutionnalisation, autodétermination, financement orienté personne) avec le cadre normatif suisse [C2, C5]
3. **Nommer** trois tensions structurelles de la posture professionnelle [C8, C9, C11]
4. **Mobiliser** un cas concret pour articuler théorie et pratique [C3, C4]

1.6 Note méthodologique

L'ensemble du matériel a été préparé à partir de :

- **64 fiches de lecture** structurées (Thèse · Concepts · Citations · Exemple BA · Limite)
- Le **PEC20** du Bachelor en travail social HES-SO
- Le **plan cantonal genevois CDPH** ([Organisation des Nations Unies, 2006](#); observations de [Comité ONU CDPH, 2022](#)) et l'**avant-projet LED-H 2024**
- Les **recherches HETS Genève** : Masse, Petitpierre, Delessert, Jacquemettaz, & Wolf ([2018](#)), Brasseur & Rodriguez ([2019](#)), Souesme ([2024](#)), Lenzi & Moine ([2025](#))

Unsupported markdown:
list



Unsupported markdown:
list



Unsupported markdown:
list



Unsupported markdown:
list



Unsupported markdown:
list



Unsupported markdown:
list



Unsupported markdown:
list



11
Unsupported markdown:
list

2 La vignette de Léa

! Situation

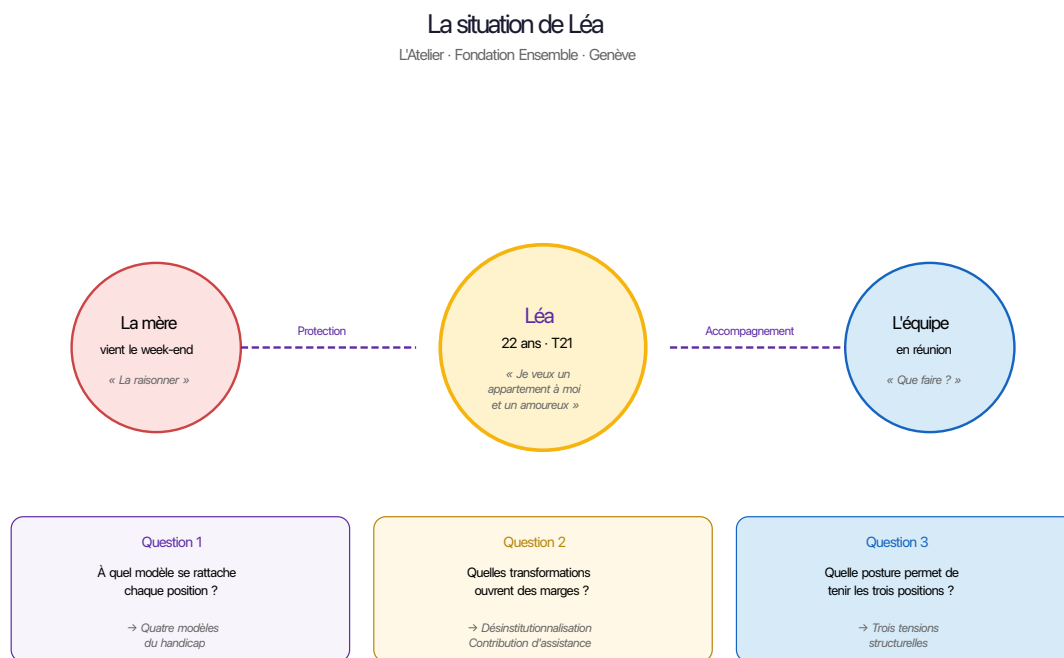
Léa, 22 ans, a une trisomie 21. Elle vit à L'Atelier, dispositif d'accompagnement des jeunes adultes géré par la Fondation Ensemble à Genève. Un matin, en réunion d'équipe, son éducatrice référente rapporte une demande :

« Je veux un appartement à moi et un amoureux qui dort là. »

La mère de Léa, qui vient chaque week-end, demande à l'équipe de *« la raisonner »*.

2.1 Une vignette comme dispositif

Cette vignette n'est pas un cas clinique fermé. C'est un **dispositif pédagogique** au sens de Schön (1994) : une situation qui résiste, qui oblige à mobiliser les ressources théoriques disponibles pour la penser. Elle est référée à un dispositif réel — L'Atelier de la Fondation Ensemble, qui accompagne effectivement des jeunes adultes avec déficience intellectuelle à Genève — sans qu'aucune personne identifiable n'y soit représentée.



Pierre Brasseur · HETS Genève · 2026 · Vignette pédagogique référée à un dispositif réel, non identifiable

Figure 2.1: Trois personnages, trois positions, trois questions à garder en tête

2.2 Trois personnages, trois positions

2.2.1 Léa

Sa demande, formulée en propres termes : « *Je veux un appartement à moi et un amoureux qui dort là.* »

Cadre normatif mobilisable :

- **CDPH art. 19** — droit de vivre dans la communauté avec la même liberté de choix que les autres
- **CDPH art. 12** — capacité juridique universelle
- **CDPH art. 22** — droit au respect de la vie privée
- **Approche par les capacités** (Nussbaum, 2006) — affiliation, contrôle de son environnement

Léa est-elle « capable » de cette vie ? Et qui en juge ?

2.2.2 La mère

Sa demande, telle qu'elle est exprimée : que l'équipe « raisonne » Léa.

Ce qu'elle mobilise implicitement :

- Une éthique de protection
- Le modèle médical-réadaptatif (déficience à compenser)
- Une expérience parentale longue, légitime, parfois douloureuse
- Possiblement une culpabilité, une fatigue, une peur

Comment travailler *avec* elle plutôt que *contre* elle ?

2.2.3 L'équipe

Sa demande, exprimée en réunion : savoir quoi faire.

Ce qui la traverse :

- Tensions de mission (protéger / soutenir l'autonomie)
- Contraintes du financement institutionnel
- Différences d'orientation entre professionnel · les
- Possiblement : peur du risque, peur de la sanction

Quelles ressources théoriques et institutionnelles mobiliser ?

2.3 Trois questions à garder en tête

Au fil de la lecture

1. À quel **modèle du handicap** se rattache chaque position ?
2. Quelles **transformations contemporaines** ouvrent des marges concrètes pour soutenir le projet de Léa ?
3. Quelle **posture professionnelle** permet de tenir ensemble les trois positions sans en écraser aucune ?

Nous revenons explicitement à la vignette à trois moments du livre :

- § Chapitre 6 — pour cartographier les positions selon les quatre modèles
- § Chapitre 9 — pour mobiliser la contribution d’assistance AI
- § Chapitre 13 — pour l’activité pédagogique *think-pair-share*

2.4 Une éthique de la vignette

⚠ Précaution

La vignette est *référée* à un dispositif réel mais *non identifiante*. Léa n’existe pas — ou plus exactement : elle n’existe pas comme cette Léa-là. Sa demande est plausible, vraisemblable, documentée par la littérature sur l’autodétermination dans le champ de la déficience intellectuelle ; sa situation reconstitue une configuration relationnelle (la mère qui demande de raisonner, l’équipe qui se demande quoi faire) que toute personne ayant fait une formation pratique en institution handicap a déjà rencontrée. Mais aucune personne identifiable n’y est représentée. C’est ce que nous appelons une **vignette dense mais désindividualisée** : suffisamment précise pour mobiliser la pensée, suffisamment générique pour protéger les personnes dont elle s’inspire.

partie II

Quatre modèles du handicap

3 Modèle médical et réadaptatif

i Thèse

Le handicap est une **déficience individuelle** à corriger par l'intervention médicale et la réadaptation fonctionnelle.

3.1 Genèse historique

Le modèle médical émerge à la fin du XIX siècle avec l'institutionnalisation de la médecine de réadaptation (Stiker, 2013). Il se consolide au sortir des deux guerres mondiales avec l'invalidité de guerre puis du travail. Sa traduction administrative la plus visible en Suisse est l'AI (LAI, RS 831.20).

« Réadapter, c'est ramener à la norme, à l'identique, et désigner par là même comme différent. »

— Stiker (2013)

3.2 Logique opérationnelle

Le handicap relève d'un diagnostic ; il appelle une intervention spécialisée (médicale, paramédicale, sociale) ; il est mesuré (taux d'invalidité, score fonctionnel) ; il ouvre des prestations en fonction de cette mesure.

3.3 Posture professionnelle qu'il appelle

Le TS comme **technicien de la conformité**. Il accompagne la personne dans son ajustement à des normes implicites de productivité, d'autonomie fonctionnelle, de comportement adapté.

3.4 Limites et critiques

Limite	Conséquence pour la pratique
Naturalise le handicap comme propriété individuelle	Occulte les déterminants environnementaux
Hierarchise diagnostic > expérience	Réduit la personne à son dossier médical
Pose la norme comme implicite	Empêche le débat sur ses critères

3.5 Persistance contemporaine

Ce modèle n'a pas disparu. Il reste structurant dans :

- L'évaluation AI ([OFAS, 2020](#))
- Les dispositifs de réadaptation professionnelle
- Certains projets personnalisés focalisés sur le « manque »
- Les logiques de financement par diagnostic

4 Modèle social (Oliver, UPIAS 1976)

i Thèse

Le handicap n'est pas la déficience corporelle (*impairment*) mais le **handicap social produit par les barrières environnementales** (*disability*).

4.1 La rupture conceptuelle

Le modèle social britannique opère une rupture épistémologique radicale. La distinction entre *impairment* et *disability* déplace la cause du handicap : ce n'est pas le corps qui handicape, c'est l'organisation sociale.

« *Disability is something imposed on top of our impairments by the way we are unnecessarily isolated and excluded from full participation in society.* »

— Union of the Physically Impaired Against Segregation (1976), repris dans Oliver (1990)

4.2 Conséquences théoriques

Avant le modèle social	Après le modèle social
Le handicap est dans la personne	Le handicap est dans l'environnement
L'intervention vise à corriger la personne	L'intervention vise à transformer l'environnement
Logique de réadaptation	Logique d'accessibilité et de droits
Personne objet de soins	Personne sujet politique

4.3 Posture professionnelle qu'il appelle

Le TS comme **acteur du changement environnemental**. Il agit moins sur la personne que sur les barrières qui la « handicapent » — barrières architecturales, communicationnelles, attitudinales, organisationnelles.

4.4 Critiques formulées depuis l'intérieur

Le modèle social a été critiqué depuis sa propre tradition, notamment par :

- Liz Crow et Sally French — pour son refus de prendre au sérieux la **souffrance corporelle** et l'**expérience subjective** de la déficience
- Tom Shakespeare (Stiker, 2013) — pour son binarisme *impairment/disability* qui rejoue un dualisme corps/société problématique
- Les *disability feminists* — pour son angle mort sur les intersections de genre, classe, racisation

4.5 Apport durable

Malgré ces critiques internes, le modèle social a structuré le mouvement international des droits des personnes handicapées et la rédaction de la **CDPH 2006** ([Organisation des Nations Unies, 2006](#)). Sa contribution centrale reste la **politisation du handicap** comme question de justice sociale, et non comme question médicale.

5 Modèle MDH-PPH (Fougeyrollas)

i Thèse

Le handicap résulte d'une **interaction** entre facteurs personnels, facteurs environnementaux et habitudes de vie. Il n'est ni dans la personne ni dans l'environnement, mais dans leur rencontre.

5.1 Origine et diffusion

Le **Modèle de développement humain – Processus de production du handicap (MDH-PPH)** est développé par Patrick Fougeyrollas et le RIPPH (Réseau international du processus de production du handicap) au Québec (Fougeyrollas, 2010). C'est le modèle francophone de référence dans le champ.

« Le handicap n'est pas une caractéristique de la personne mais le résultat contextuel d'une interaction. »

— Fougeyrollas (2010)

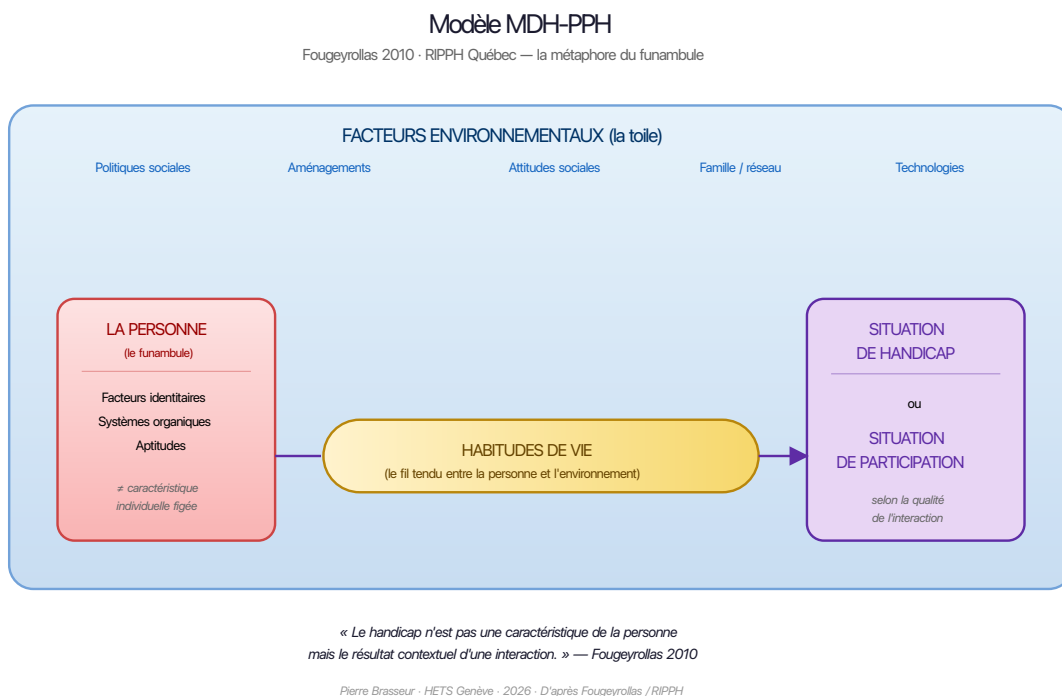


Figure 5.1: Le funambule, le fil et la toile — métaphore centrale du MDH-PPH

5.2 La métaphore du funambule

La personne (funambule) avance sur un fil (habitudes de vie) tendu dans une toile (environnement). Une **situation de handicap** survient quand la qualité de la toile ne soutient pas le passage. **Inversement**, une situation de participation sociale survient quand la toile soutient.

Élément	Catégorie	Exemples
Le funambule	Facteurs personnels	Systèmes organiques, aptitudes, facteurs identitaires
Le fil	Habitudes de vie	Activités courantes, rôles sociaux valorisés
La toile	Facteurs environnementaux	Politiques sociales, aménagements, attitudes, technologies, famille

5.3 Posture professionnelle qu'il appelle

Le TS comme **évaluateur situationnel**. Il cartographie les facilitateurs et les obstacles dans l'environnement de la personne, identifie les habitudes de vie compromises, négocie des aménagements.

5.4 Diffusion en Suisse romande

C'est ce modèle qui structure la recherche romande sur l'accessibilité et la participation sociale, notamment à la HETS Genève (Masse et al., 2018). L'outil **MHAVIE** (Mesure des habitudes de vie) en dérive directement. Cette approche a permis d'analyser 47 institutions romandes auprès d'environ 7 000 adultes avec déficience intellectuelle.

5.5 Limite opérationnelle

⚠ Difficulté de mise en œuvre

Le MDH-PPH est complexe — c'est sa force conceptuelle. Mais cette complexité le rend parfois difficile à opérationnaliser dans des dispositifs administratifs qui exigent des catégorisations fixes (l'AI ne sait pas évaluer une « situation de handicap variable »).

Le TS qui mobilise le MDH-PPH doit savoir **traduire** : produire des évaluations standardisées pour les financeurs *et* maintenir une lecture dynamique en équipe.

6 Modèle droits + capacités

i Thèse

La personne handicapée est **sujet de droits égaux**. Ce qui compte est la **capabilité réelle** — ce que la personne peut effectivement faire et être.

Ce quatrième modèle émerge à la jonction de deux traditions distinctes mais convergentes : le droit international des droits humains et la philosophie politique post-rawlsienne.

6.1 Pilier juridique : la CDPH ONU 2006

La **Convention relative aux droits des personnes handicapées** ([Organisation des Nations Unies, 2006](#)) consacre le passage d'une approche de protection (charity, welfare) à une approche de droits (rights-based). La Suisse a ratifié la CDPH le **15 avril 2014**.

6.1.1 Trois articles structurants

Article	Objet	Portée pour le TS
Art. 12	Capacité juridique universelle	Passage de la substitution au soutien à la décision
Art. 19	Vie autonome dans la communauté	Cadre de la désinstitutionnalisation
Art. 24	Éducation inclusive	Cadre de l'école inclusive et de la formation pro

6.1.2 Citation cadre

« Reconnaissent que la notion de handicap évolue et que le handicap résulte de l'interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. »

— Organisation des Nations Unies ([2006](#)), Préambule (e)

6.2 Pilier philosophique : l'approche par les capacités

L'**approche par les capacités** initiée par Amartya Sen et systématisée pour les personnes handicapées par Martha Nussbaum ([Nussbaum, 2006](#)) propose une alternative au contractualisme rawlsien.

Pour Nussbaum, la *Théorie de la justice* échoue à inclure les personnes lourdement handicapées car elle présuppose des contractants libres, rationnels et productifs. L'approche par les capacités garantit à chacun · e un seuil minimal de **dix capacités centrales** comme conditions d'une vie digne.

6.2.1 Les dix capacités centrales

1. Vie
2. Santé corporelle
3. Intégrité corporelle
4. Sens, imagination, pensée
5. Émotions
6. Raison pratique
7. **Affiliation** (vivre avec et pour les autres)
8. Autres espèces
9. **Jeu**
10. **Contrôle de son environnement** (politique et matériel)

6.3 Posture professionnelle qu'il appelle

Le TS comme **garant de droits** et **facilitateur de capacités**. Il connaît le cadre légal, sait l'invoquer, sait l'expliquer ; il évalue moins des « besoins » ou des « manques » que des **capacités à soutenir**.

6.4 Retour à Léa

Appliquons les quatre modèles à la situation de Léa.

Modèle	Lecture de la situation	Action suggérée
Médical	Trisomie 21, déficience intellectuelle, demande à <i>évaluer</i>	Bilan cognitif et fonctionnel
Social	Cadre institutionnel inadapté à l'habitat individuel	Transformer les dispositifs disponibles
MDH-PPH	Habitudes de vie (vie affective, habitat) compromises par l'environnement	Cartographier obstacles/facilitateurs
Droits + capacités	Capacités d'affiliation et de contrôle de son environnement à soutenir	Mobiliser CDPH art. 12, 19, 22 et la contribution d'assistance

Aucune lecture n'est *fausse*. Chacune est **incomplète**. La posture professionnelle consiste à mobiliser plusieurs grammaires simultanément.

6.5 Limite



Effectivité variable

Les droits proclamés ne sont pas les droits effectifs. La Suisse a été critiquée par le Comité ONU CDPH ([Comité ONU CDPH, 2022](#)) pour le retard sur la désinstitutionnalisation (art. 19) et la capacité juridique (art. 12). Le modèle droits + capacités ne suffit pas — il ouvre un horizon normatif que le TS doit contribuer à rendre **effectif**, dans la lignée de l'analyse des **droits vulnérables** ([Revillard, 2020](#)).

partie III

Transformations contemporaines

7 Désinstitutionnalisation

i Thèse

La désinstitutionnalisation n'est pas la simple fermeture des établissements. C'est la mise en place de services de proximité de qualité, individualisés. Sans cet investissement, elle produit de la transinstitutionnalisation et aggrave le non-recours.

7.1 Cadre normatif

L'article 19 CDPH pose le droit de « *vivre dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes* ». Sa mise en œuvre est précisément ce que le Comité ONU CDPH a critiqué dans ses Observations finales sur la Suisse du 13 avril 2022 (Comité ONU CDPH, 2022).

« *The Committee is concerned about the lack of a comprehensive deinstitutionalization strategy.* » (§ 41)

« *Adopt a deinstitutionalization strategy with a clear time frame.* » (§ 42)

7.2 Mobilisation politique suisse

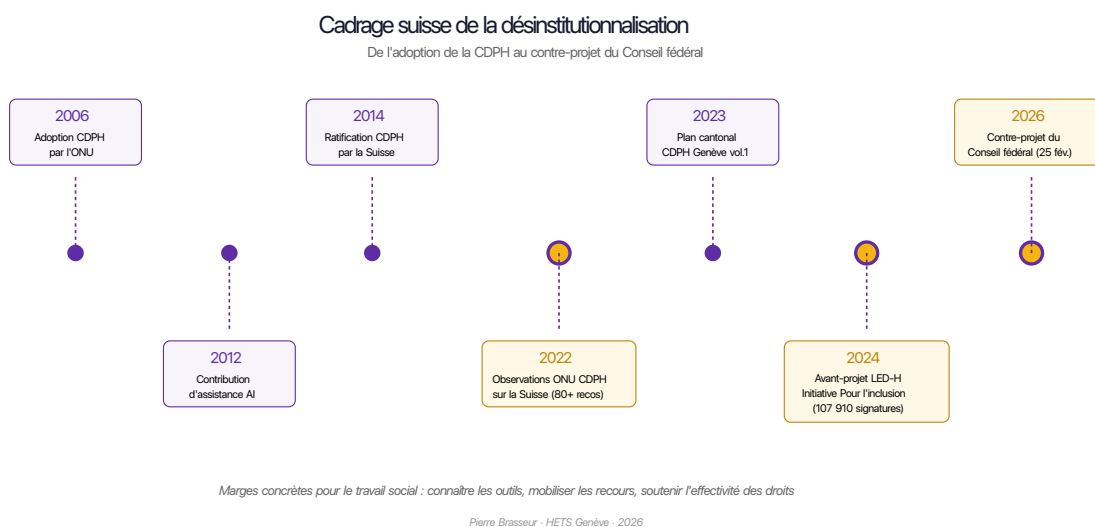


Figure 7.1: Frise chronologique 2006-2026

Année	Évènement
2014	Ratification CDPH par la Suisse (15 avril)

Année	Évènement
2022	Observations finales du Comité ONU CDPH (80+ recommandations)
2023	Plan cantonal genevois CDPH, volume 1 (janvier)
2024	Avant-projet LED-H en consultation (12 juin) ; Initiative populaire fédérale <i>Pour l'inclusion</i> — 107 910 signatures (5 septembre)
2026	Contre-projet du Conseil fédéral, message du 25 février

7.3 Précisions critiques

⚠ La qualité ne dépend pas de la taille

La position de l'IASSIDD, formalisée par Mansell & Beadle-Brown (2010), est sans équivoque :

« *Community-based services are typically associated with better outcomes than institutional provision, but outcomes vary widely depending on how services are organised.*
» (Mansell & Beadle-Brown, 2010, p. 106)

Sans investissement substantiel dans les services de proximité, la fermeture des grands établissements produit :

- **Transinstitutionnalisation** — déplacement vers d'autres formes de ségrégation (hôpital psychiatrique, prison, rue)
- **Aggravation du non-recours** — les personnes concernées n'accèdent plus aux services dont elles auraient besoin
- **Charge accrue sur les familles** — délégation informelle aux proches, surtout aux femmes

L'**ENIL** (European Network on Independent Living) documente que des fonds structurels européens continuent à financer la rénovation d'institutions au lieu de l'assistance personnelle.

7.4 Pour le travail social

Action	Outils mobilisables
Évaluer la qualité des alternatives	Indicateurs IASSIDD, MHAVIE
Activer les droits	CDPH art. 19, contribution d'assistance AI
Articuler le réseau	Pro Infirmis, Cap-Contact, INSOS Genève
Soutenir la transition	Pair-aidance (Souesme, 2024), préparation graduée

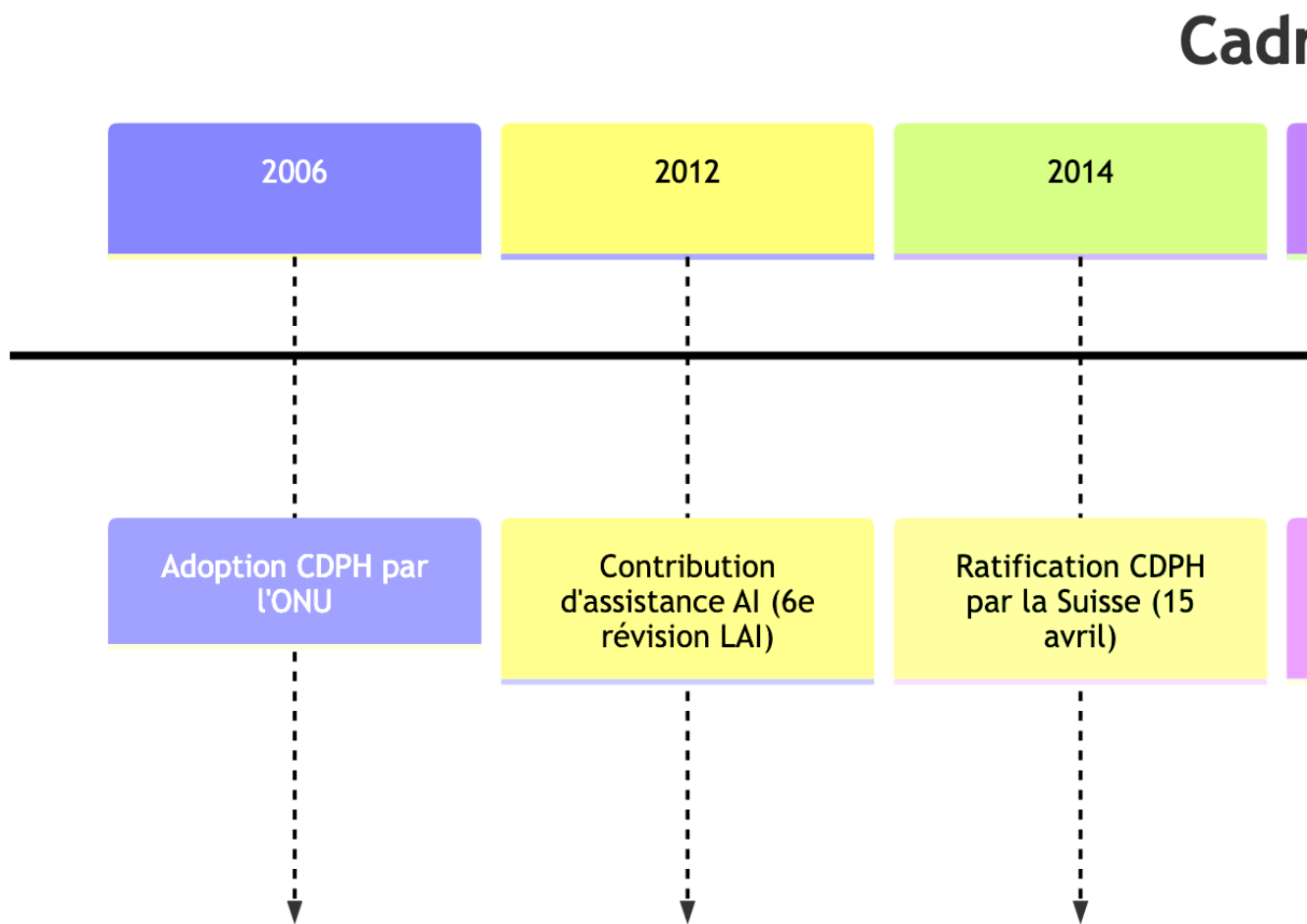


Figure 7.2: Jalons suisses de l'inscription des droits du handicap

8 Autodétermination, agentivité, pair-aidance

i Thèse

L'autodétermination n'est pas un trait individuel à entraîner. C'est un produit relationnel et écosystémique, soutenu par des opportunités d'apprentissage et par la reconnaissance des savoirs expérientiels.

8.1 Théorie de l'autodétermination

Ryan & Deci (2017) identifient trois besoins psychologiques fondamentaux **universels** qui conditionnent la motivation, le bien-être, l'engagement :

1. **Autonomie** — agir en accord avec ses valeurs
2. **Compétence** — éprouver son efficacité
3. **Appartenance** — appartenir, être relié

« Autonomy, competence, and relatedness are not just preferences but universal psychological necessities. » (Ryan & Deci, 2017, p. 86)

8.2 Le modèle fonctionnel de Wehmeyer

Wehmeyer (1996) propose une opérationnalisation centrée sur le concept d'**agent causal** : agir comme le principal agent causal de sa propre vie.

8.2.1 Quatre caractéristiques

Caractéristique	Question test
Autonomie comportementale	La personne agit-elle selon ses préférences ?
Autorégulation	La personne sait-elle ajuster son action ?
<i>Empowerment</i> psychologique	La personne croit-elle pouvoir agir sur sa vie ?
Autoréalisation	La personne se connaît-elle suffisamment ?

8.3 L'enjeu opérationnel

Trois postures à distinguer

- **Contrôler** l'autonomie de la personne accompagnée
- **Contraindre** son autonomie
- **Soutenir** son autonomie (*autonomy support*)

Seule la troisième posture est compatible avec l'autodétermination. Les deux premières sont fréquentes en institution — sous des apparences bienveillantes.

8.4 Savoirs expérientiels et pair-aidance

La cartographie pionnière de Jouet, Flora, & Las Vergnas (2010) a documenté la production de savoirs spécifiques par les personnes concernées.

« Les patients développent, au fil de l'expérience de la maladie, des savoirs spécifiques qui ne sont pas réductibles aux savoirs médicaux. » (Jouet et al., 2010)

À Genève, plusieurs recherches HETS portent sur la pair-aidance et l'habitat autonome dans le champ de la déficience intellectuelle (Masse et al., 2018; Souesme, 2024).

8.5 Vigilance épistémique

La division témoin / expert

Malgré la rhétorique participative, une division du travail épistémique persiste : les personnes handicapées sont mobilisées comme **témoins**, tandis que les valides occupent les positions d'**experts** (Brasseur & Rodriguez, 2019).

« Les personnes handicapées sont invitées à témoigner de leur expérience pendant que les valides en produisent l'analyse. La participation se déploie selon une économie inégale de la parole. »

La pair-aidance institutionnalisée doit s'accompagner d'un travail réflexif et structurel — **statut, rémunération, formation, supervision** — sans lequel elle risque de devenir une nouvelle injonction.

9 Financement orienté personne

i Thèse

Le financement orienté personne (*cash-for-care*) déplace l'argent du soin de l'institution vers la personne. Il ouvre une marge d'autodétermination, mais redistribue aussi les charges de coordination, de gestion, de risque.

9.1 La contribution d'assistance AI

Introduite le 1 janvier 2012 par la 6^e révision LAI. Logique *cash-for-care* : la personne reçoit l'argent et engage elle-même ses assistants.

9.1.1 Chiffres clés

Indicateur	Valeur
Bénéficiaires fin 2019	~ 2 600 (cible initiale 3 000 dès 2012)
Durée moyenne d'engagement	41 h/semaine
Satisfaction	81 % satisfaits ou très satisfaits
Retours en home	Rares

Source : OFAS (2020).

9.2 Critiques structurelles

- **Barrières administratives** lourdes (formulaire, calcul des besoins, statut employeur-bénéficiaire)
- **Pénurie d'assistants** disponibles dans certaines régions
- **Non-extension aux mineurs** et aux personnes en **curatelle de portée générale**
- **Inégalités d'accès** selon la capacité à gérer (faire les démarches, recruter, suivre les comptes)

9.3 Mise en perspective comparée

Pays	Dispositif	Année	Critique principale
Suisse	Contribution d'assistance AI	2012	Diffusion limitée, complexité admin.
France	PCH	2005	Familialisme par défaut
Angleterre	<i>Direct payments / Individual budgets</i>	1996 / 2003	Inégalités de capacité à gérer

Pays	Dispositif	Année	Critique principale
Pays-Bas	Budget personnel (PGB)	1995	Précarisation des care workers

Le Bihan, Da Roit, & Sopadzhyan (2019) analysent ces politiques comme un « *familialisme optionnel par le marché* » — risque de précarisation des aidant · es professionnel · les, souvent migrant · es. Glendinning (2008) observe :

« *Personalisation marks a shift from the citizen-as-recipient to the citizen-as-purchaser of care.* »

Ce déplacement n'est pas neutre. Il introduit une logique de marché dans le soin.

9.4 Retour à Léa

La contribution d'assistance constitue **l'un** des outils qui rendraient son projet juridiquement possible :

- Léa **n'est pas** sous curatelle de portée générale → elle est **éligible**
- Elle aurait à embaucher elle-même ses assistant · es
- Elle conserverait son logement choisi

! Mais

Sait-elle qu'elle existe ? Sait-elle remplir le formulaire ? Connaît-elle ses droits de recours ?

« *Les droits ne sont pas seulement ce que les textes disent, mais ce que les personnes parviennent à en faire.* » (Revillard, 2020)

Le TS est un opérateur clé de l'effectivité. À Genève : Pro Infirmis, Cap-Contact, services sociaux institutionnels.

partie IV

Posture professionnelle

10 Tension protection / autonomie

i Thèse

La dignité du risque (Perske, 1972) et le paradigme du soutien à la décision (CDPH art. 12) déplacent la question. L'enjeu n'est pas « protéger ou laisser faire » mais **redistribuer la responsabilité du care** (Tronto, 2009).

10.1 La dignité du risque (Perske 1972)

Perske (1972) formule en 1972 ce qui demeure l'une des phrases les plus citées du champ :

« There can be such a thing as human dignity in risk. And there can be a dehumanizing indignity in safety! »

La dignité du risque signifie que les personnes ayant une déficience intellectuelle ont droit à prendre des **risques ordinaires** : travailler, aimer, voyager, se tromper. Surprotéger nie l'humanité de la personne.

10.2 Le déplacement juridique (CDPH art. 12)

L'article 12 CDPH opère le déplacement correspondant :

Avant	Après
Paradigme tutélaire	Paradigme du soutien
Substitution de décision	<i>Supported decision-making</i>
Curatelle de portée générale	Mesures graduées et personnalisées
Capacité juridique restreinte	Capacité juridique universelle

En Suisse, l'application reste partielle. La curatelle de portée générale (CC art. 398) demeure couramment ordonnée, en contradiction avec la lecture stricte soutenue par le Comité ONU CDPH (Comité ONU CDPH, 2022).

10.3 L'éthique du care comme cadre théorique

La résolution de cette tension n'est pas dans le choix univoque de l'autonomie contre la protection. Elle est dans une **éthique du care** qui pense la vulnérabilité comme constitutive de la condition humaine (Paperman & Laugier, 2011; Tronto, 2009).

« Nous sommes tous des êtres vulnérables et dépendants. Il s'agit de redistribuer la responsabilité du care, non de la concentrer sur les plus faibles. » (Tronto, 2009)

Tronto (2009) déplace le care de l'éthique privée vers la philosophie politique. Une démocratie *caring* reconnaît que la vulnérabilité est universelle et redistribue les responsabilités au lieu de les confiner aux femmes, aux racisé·es, aux pauvres.

10.4 Implications pour le travail social

Quatre questions à se poser

1. **Qui** décide du niveau de risque acceptable ?
2. **Sur quels critères** la décision se fonde-t-elle ?
3. **Comment** la décision est-elle documentée et révisable ?
4. **Quelle redistribution** des responsabilités la décision opère-t-elle ?

Ces quatre questions transforment la tension protection/autonomie en **objet de travail collectif** plutôt qu'en dilemme individuel.

11 Tension expertise / savoir expérientiel

i Thèse

La formule « *Nothing about us without us* » (Charlton, 1998) est une épistémologie politique, pas un slogan. Elle requiert quatre conditions opérationnelles pour produire ses effets : co-construction structurelle, pluralité représentée, rétribution, transparence sur les rapports de pouvoir.

11.1 La formule fondatrice

« *Nothing about us without us.* »

« *Disability oppression is a totalizing system.* »

— Charlton (1998)

La phrase fonde le mouvement international des droits des personnes handicapées et a guidé la rédaction de la CDPH 2006. C'est une **épistémologie politique** — pas seulement une exigence de participation à la décision, mais à la production des catégories à partir desquelles la décision est pensée.

11.2 Transformations institutionnelles

Le déplacement épistémologique de Charlton se traduit institutionnellement par :

- La **pair-aidance** dans le champ DI et en santé mentale
- L'**auto-représentation associative** — AGILE.CH, Cap-Contact, *self-advocacy groups*
- La **co-recherche** et la mobilisation des savoirs expérientiels (Jouet et al., 2010)

11.3 Vigilance épistémique

⚠ La division témoin / expert

Malgré la rhétorique participative, une division du travail épistémique persiste.

« *Les personnes handicapées sont invitées à témoigner de leur expérience pendant que les valides en produisent l'analyse.* » (Brasseur & Rodriguez, 2019)

La participation se déploie selon **une économie inégale de la parole** :

- La parole concernée est mobilisée comme **témoignage** (premier moment de la journée d'étude, 15 minutes)
- La parole valide est mobilisée comme **analyse** (plénière de 90 minutes, conférenciers universitaires)

Cette division reproduit l'asymétrie qu'elle prétend défaire.

11.4 Conditions opérationnelles

Pour que la formule de Charlton produise ses effets, **quatre conditions** :

11.4.1 1. Co-construction structurelle

Les dispositifs sont conçus avec les personnes concernées **dès leur formation** — pas une fois qu'ils sont écrits. Cela suppose de la planification, du temps, du budget.

11.4.2 2. Pluralité représentée

Aucun individu ne représente *les* personnes handicapées. La participation doit refléter la pluralité des positions (déficiences, classes, genres, âges, parcours, intersections).

11.4.3 3. Rétribution et formation

La participation est un **travail**. Elle doit être rétribuée à un niveau équivalent aux autres participations expertes. Quand elle suppose une montée en compétence (lecture de rapports, mobilisation de cadres juridiques), une **formation** doit être proposée.

11.4.4 4. Transparence sur les rapports de pouvoir

Les personnes valides en position d'autorité reconnaissent leur position et travaillent à la déplacer. Sans ce travail, la participation reste asymétrique.

Question	Vérification
----------	--------------

11.5 Pour le travail social

Question	Vérification
Le projet personnalisé est-il co-construit ?	La personne y reconnaît-elle sa propre formulation ?
Le règlement institutionnel est-il négocié ?	Existe-t-il une instance de représentation des usager · es ?
Les évaluations mobilisent-elles le savoir expérientiel ?	Comment ce savoir est-il documenté et valorisé ?
Les évaluations sont-elles accessibles aux usager · es ?	Le langage utilisé est-il en FALC ?

12 Tension travail prescrit / travail réel

i Thèse

Le travail prescrit n'est jamais identique au travail réel. La clinique de l'activité (Clot, 2008) et la *street-level bureaucracy* (Lipsky, 2010) outillent cette tension. Les marges du métier (Lenzi & Moine, 2025) en sont le lieu d'invention professionnelle.

12.1 La clinique de l'activité

Clot (1999) et Clot (2008) développent la grammaire conceptuelle de cette tension.

12.1.1 Distinction centrale

Niveau	Définition
Travail prescrit	Référentiels d'activité, procédures, contraintes du financement
Activité réalisée	Ce qui est effectivement fait dans la situation
Réel de l'activité	Inclut aussi ce qui n'est pas fait, ce qui aurait pu être fait, ce qui est empêché

« Ce qui rend malade au travail, ce n'est pas le conflit, c'est l'impossibilité du conflit. » (Clot, 2008)

12.1.2 Concepts clés

- **Genre professionnel** — manières de faire propres au métier, déposées dans le collectif
- **Style** — manière personnelle de mobiliser le genre
- **Pouvoir d'agir** — possibilité effective d'agir sur son milieu et sur soi-même
- **Activité empêchée** — ce qu'on ne peut pas faire malgré sa volonté de bien faire

12.2 La *street-level bureaucracy*

Lipsky (2010) fournit la sociologie politique de cette tension.

« The decisions of street-level bureaucrats, the routines they establish, and the devices they invent to cope with uncertainties and work pressures effectively become the public policies they carry out. » (Lipsky, 2010, p. xii)

Les travailleur·euses sociaux·ales ne sont pas seulement des **exécutant·es**. Elles sont des **producteur·trices de politique publique au guichet**, exerçant une *autonomie discrétionnaire* qui peut être :

- un **levier d'éthique professionnelle** (mobiliser une marge pour faire au mieux)
- ou une zone de **reproduction inégalitaire** (routiniser, écrémer, simplifier)

Dubois (2010) en a tiré une ethnographie de référence du guichet.

12.3 Les marges du métier

Lenzi & Moine (2025) viennent de prolonger cette tradition avec un ouvrage qui rassemble des analyses de l'autonomie discrétionnaire **dans les marges** des dispositifs.

12.4 Le travail émotionnel

Une dimension reste sous-thématisée dans la clinique de l'activité : le **travail émotionnel** (Hochschild, 1983).

« *This labor requires one to induce or suppress feeling in order to sustain the outward countenance that produces the proper state of mind in others.* » (Hochschild, 1983, p. 7)

Annoncer un refus AI, accompagner une fin de droits, recadrer un proche : autant de situations où le travail émotionnel est central, **invisible dans les fiches de poste**, coûteux psychologiquement.

Catherine Lenzi est professeure associée à la HETS Genève et anime le réseau de compétences « Autonomie-Handicap-Dépendance ».

12.5 Le praticien réflexif

Schön (1994) rappelle que les professionnel·les compétent·es ne se contentent pas d'appliquer des savoirs académiques (rationalité technique) mais conduisent une *reflection-in-action* qui leur permet d'affronter incertitude, singularité, conflits de valeurs.

« *Les praticiens compétents en savent généralement plus qu'ils ne peuvent en dire.* » (Schön, 1994)

12.6 Synthèse opérationnelle

Outil théorique	Question pour la pratique
Clinique de l'activité <i>Street-level bureaucracy</i>	Quelle est mon activité empêchée aujourd'hui ? Quelle marge discrétionnaire ai-je mobilisée cette semaine ?
Travail émotionnel	Quelles émotions ai-je dû gérer pour faire mon travail ?
Praticien réflexif	Que m'a appris cette situation que je ne savais pas avant ?

partie V

Application

13 Activité et synthèse

! Retour à la vignette

La vignette de Léa (§ Chapitre 2) clôt la séance par une activité *think-pair-share*. L'objectif est de transformer la pluralité des modèles en posture argumentée.

13.1 Consigne de l'activité (5 minutes)

13.1.1 Étape 1 — Seul · e (2 minutes)

Choisissez l'une des trois tensions :

- Protection / Autonomie
- Expertise / Savoir expérientiel
- Travail prescrit / Travail réel

Prenez position individuellement.

13.1.2 Étape 2 — En binôme (2 minutes)

Formulez en **deux phrases** ce que vous diriez à :

- Léa
- sa mère
- l'équipe

Il n'y a pas de bonne réponse — une posture argumentée.

13.1.3 Étape 3 — Restitution (1 minute)

Trois binômes restituent, un par tension. Le formateur reformule en renvoyant aux concepts mobilisés.

13.2 Posture du formateur

Facilitateur, pas évaluateur. Circuler, reformuler, renvoyer aux concepts.

Si un binôme dit...	Reformulation
« On respecte le choix de Léa. »	« Vous mobilisez la dignité du risque (<i>Perske, 1972</i>) et l'art. 12 CDPH. »

Si un binôme dit...	Reformulation
« On protège Léa. »	« Vous mobilisez l'éthique de protection. Quels critères justifieraient-ils de limiter sa capacité juridique ? »
« On en discute avec la mère. »	« Vous mobilisez l'éthique du care de Tronto (Tronto, 2009). Comment éviter qu'elle ne devienne substitution de décision ? »
« On évalue la contribution d'assistance. »	« Vous activez un droit social. Connaissez-vous les barrières administratives identifiées par OFAS (2020) ? »

13.3 Trois acquis à retenir

💡 Acquis 1 — Les modèles coexistent

Les quatre modèles du handicap **ne sont pas des étapes successives** mais des **grammaires actives** qui coexistent dans chaque institution.

*« Le handicap n'est pas un donné mais un construit historique, social et politique. »
(Ville, Fillion, & Ravaud, 2020)*

💡 Acquis 2 — Des marges concrètes pour le TS

Les transformations contemporaines suisses ouvrent des **marges d'action concrètes** — CDPH, contribution d'assistance AI, Initiative *Pour l'inclusion* 2024, plan cantonal genevois 2023, avant-projet LED-H.

Mais ces marges sont des **droits vulnérables** dont l'effectivité dépend du travail d'intermédiation (Revillard, 2020).

💡 Acquis 3 — Une posture comme travail réflexif

La posture professionnelle **n'est pas un trait personnel**. C'est un **travail réflexif quotidien** sur trois tensions structurelles. L'enjeu n'est pas de les résoudre mais de les habiter de manière argumentée.

*« Les praticiens compétents en savent généralement plus qu'ils ne peuvent en dire. »
(Schön, 1994)*

13.4 Ouverture sur la séance 5

La séance suivante portera sur :

« Le travail avec les proches : entre alliés, opposants et co-aidants. »

La mère de Léa nous y accompagne. Les étudiant·es sont invité·es à apporter une situation rencontrée en formation pratique où la famille les a déstabilisé·es — anonymisée, sans lieu identifiable.

13.5 Lectures recommandées

Référence	Pour quoi ?
Ville et al. (2020)	Manuel de référence du module
Lenzi & Moine (2025)	Posture et marges du métier
Comité ONU CDPH (2022)	Articles 12, 19, 24
Brasseur & Rodriguez (2019)	Vigilance épistémique

14 Auto-évaluation

Mode d'emploi

Cinq exercices courts pour vérifier la mobilisation des concepts. **Ouvrez chaque bloc Réponse après avoir réfléchi.** Aucune note — outil de révision avant le travail intermédiaire (séance 7 du module complet).

14.1 Exercice 1 — Reconnaître les modèles

Dans une institution genevoise, un règlement stipule : « *L'utilisateur doit faire la preuve de ses progrès d'autonomie avant tout passage en habitat individuel.* »

À quel modèle du handicap ce règlement renvoie-t-il principalement ?

Réponse

Modèle médical-réadaptatif.

Trois indices :

- Le langage du « progrès » et de la « preuve » : la personne doit s'ajuster à une norme implicite de productivité comportementale
- L'autonomie est posée comme **attribut individuel** à acquérir, non comme capacité à soutenir
- L'environnement (la disponibilité d'un habitat accompagné) n'est pas interrogé

Contraste : l'art. 19 CDPH pose le **droit de vivre dans la communauté avec la même liberté de choix**. Une lecture *droits + capacités* renverserait la charge de la preuve.

14.2 Exercice 2 — Distinguer impairment et disability

Une étudiante en FP rapporte : « *Mon résident en fauteuil n'arrive jamais à temps au repas parce que le couloir est trop étroit pour qu'on puisse y croiser une autre personne en fauteuil.* »

Où se situe le handicap dans cette situation ?

Réponse

Le **fauteuil** et la difficulté motrice relèvent de l'**impairment**.

Le fait d'arriver en retard au repas relève de la **disability**.

Cause : la largeur du couloir, donc l'**environnement bâti**. Modèle social (Oliver, 1990) : « *It is society which disables physically impaired people.* »

Pour le TS : l'intervention pertinente n'est pas (seulement) sur la personne mais sur le bâti. Note la convergence avec la LHand (RS 151.3) qui pose des obligations d'accessibilité.

14.3 Exercice 3 — Mobiliser une capacité

Une personne polyhandicapée sans communication verbale, en foyer, ne participe à aucune activité collective. L'équipe écrit dans le projet personnalisé : « *Bien-être de base assuré.* »

Que dirait Nussbaum ?

Réponse

Les **dix capacités centrales** (Nussbaum, 2006) posent un seuil minimal pour qu'une vie soit *worthy of human dignity*. Y figurent notamment :

- **L'affiliation** (vivre avec et pour les autres)
- **Le jeu** (rire, jouer, profiter d'activités récréatives)
- **Le contrôle de son environnement** (au sens matériel et politique)

Réduire l'évaluation au « bien-être de base » (soins, hygiène, alimentation), c'est **passer sous silence ces capacités**. La personne est traitée comme objet de soin, non comme sujet d'une vie digne.

Le TS qui mobilise Nussbaum dans son évaluation oblige l'équipe à se demander : *que faisons-nous pour soutenir l'affiliation et le jeu ?*

14.4 Exercice 4 — Identifier la tension

Une éducatrice rapporte : « *Léa veut prendre seule le tram pour aller travailler. Le règlement de l'institution interdit la circulation seule. La cheffe d'équipe dit que c'est pour notre protection juridique.* »

Quelle tension est à l'œuvre ? Quels outils mobiliser ?

Réponse

Tension protection / autonomie.

Outils théoriques :

- **Dignité du risque** (Perske, 1972) : « *There can be such a thing as human dignity in risk. And there can be a dehumanizing indignity in safety!* »
- **Art. 12 CDPH** : capacité juridique universelle, paradigme du soutien à la décision
- **Éthique du care** (Tronto, 2009) : redistribuer la responsabilité du care plutôt que confiner la personne dans un statut de protégée

Outils pratiques :

- Travail d'équipe sur les **critères** d'évaluation du risque
- Articulation avec la **clinique de l'activité** (Clot, 2008) : que dit le « règlement » du *travail prescrit* qui empêche l'équipe d'exercer son métier ?
- Médiation avec la cheffe d'équipe en mobilisant le cadre légal

14.5 Exercice 5 — Activer un droit vulnérable

Léa pourrait théoriquement vivre en appartement avec une contribution d'assistance AI. Elle ne le sait pas. L'équipe ne mobilise pas le dispositif. Sa mère s'oppose.

Qu'est-ce que Revillard nous apprend de cette situation ?

Réponse

Concept central : **droits vulnérables** (Revillard, 2020).

« Les droits ne sont pas seulement ce que les textes disent, mais ce que les personnes parviennent à en faire. »

Trois mécanismes de vulnérabilité :

1. **Méconnaissance** — Léa ignore l'existence du droit
2. **Médiation institutionnelle défaillante** — l'équipe ne joue pas son rôle d'intermédiaire informationnel
3. **Opposition relationnelle** — la mère exerce une influence qui peut conduire à un renoncement informel

Le TS est un **opérateur clé de l'effectivité**. Trois leviers :

- Information directe à Léa (en FALC si pertinent)
- Travail avec la mère sur ses craintes (éthique du care)
- Mobilisation du réseau : Pro Infirmis Genève, Cap-Contact, OAI

Conclusion

i Quatre intuitions à garder

1. **Les modèles coexistent** comme grammaires actives, pas comme étapes successives
2. **Les transformations suisses ouvrent des marges concrètes** pour le TS, mais les droits sont vulnérables
3. **La posture professionnelle est un travail réflexif quotidien** sur trois tensions structurelles
4. **La vignette est un outil d'apprentissage**, pas un cas-école — son efficacité tient à la résistance qu'elle oppose

Ce que cet ouvrage n'est pas

Cet ouvrage **n'est pas** :

- Un manuel exhaustif du champ du handicap — pour cela, voir Ville et al. (2020)
- Un guide opérationnel d'application des cadres juridiques — pour cela, voir les ressources de Pro Infirmis et d'Inclusion Handicap
- Une critique radicale des institutions — pour cela, voir les *crip studies* et certains textes de Charlton, Ravaud, Goodley
- Une synthèse de la sociologie de la maladie ou du soin — pour cela, voir les travaux de Pierre Aïach, Isabelle Baszanger ou Aurélien Troisœufs

Il est ce qu'il est : un **matériel pédagogique** destiné à une séance de cours de 40 minutes (et son module d'inscription), suffisamment structuré pour outiller un·e étudiant·e Bachelor TS du semestre 4, suffisamment ouvert pour ne pas refermer prématurément des questions vives.

Travail à venir

Plusieurs chantiers prolongent ce travail :

- Une **séance 5** sur le travail avec les proches
- Un module **Bachelor de spécialisation** sur 13 séances dont ce livre détaille la séance 4
- Des **chapitres complémentaires** sur l'école inclusive, la pair-aidance approfondie, et les violences institutionnelles
- Un **module de formation continue** pour les TS en poste, en partenariat avec INSOS Genève

Remerciements

Ce travail doit beaucoup aux collègues romand·es dont les recherches structurent le module — **Manon Masse, Catherine Lenzi, Chloé Souesme, Yves Delessert, Geneviève Piérart, Barbara Lucas** — et aux personnes concernées rencontrées en formation pratique et en recherche, dont les questions ont façonné les miennes.

Il doit beaucoup aussi aux étudiant·es des promotions passées, à l’Université de Lille puis à l’Université libre de Bruxelles, dont les objections ont raffiné les arguments.

Contact

pierre.brasseur@hetsge.ch — toute correction, prolongement, critique est bienvenu.

A Cadre suisse et genevois

A.1 Cadre légal fédéral

Texte	Référence	Année	Points-clés
Constitution fédérale	art. 8 al. 2 et 4, art. 112b	2000	Interdiction de discrimination, intégration
LHand	RS 151.3	2002 (rév. 2024)	Élimination des inégalités, extension aux privés en discussion
LAI	RS 831.20	1959 (6 rév. 2012)	Rentes, réadaptation, contribution d'assistance
LIPPI	RS 831.26	2006	Subventions fédérales aux institutions
CDPH ONU	Ratifiée 15.04.2014	2006	Sujets de droits égaux

A.2 Cadre légal genevois

Texte	Référence	Année	Points-clés
LIPH-GE	K 1 36	2003	Loi cantonale, instaure les EPI
LIMAD	K 1 07	2011	Établissement autonome de droit public imad
Plan cantonal CDPH	volume 1	janvier 2023	Mise en œuvre cantonale
Avant-projet LED-H	en consultation	12 juin 2024	Co-construit avec ~40 organisations

A.3 Initiative *Pour l'inclusion*

- Déposée **5 septembre 2024**
- **107 910 signatures validées** sur 109 110
- **Demandes** : égalité, participation, autodétermination, droit à l'assistance personnelle (inscription constitutionnelle)
- **Contre-projet du Conseil fédéral** : message du 25 février 2026, jugé en-deçà par Inclusion Handicap et AGILE.CH

A.4 Acteurs institutionnels genevois

A.4.1 Administration cantonale

Acteur	Statut	Rôle
DCS — Département de la cohésion sociale	État	Tutelle politique
OAIS — pôle handicaps	DCS	Mise en œuvre opérationnelle
Commission cantonale d'indication (CCI)	DCS	Orientation vers les EPH
OAI Genève	État	Application LAI au niveau cantonal
imad	Établissement autonome	Maintien à domicile
SCOPSE	État	Contrôle qualité des EPH

A.4.2 Faïtières

Organisation	Niveau	Spécificité
INSOS Genève	Cantonal	Faïtière des institutions (président : J. Laederach)
fégaph	Cantonal	22 organisations membres
Pro Infirmis Genève	Cantonal	Consultation sociale, conseil spécialisé
Cap-Contact	Romand	Droits, axe domicile
Inclusion Handicap	National	Faïtière nationale (Berne)
AGILE.CH	National	45 orgs <i>de</i> personnes handicapées (créée 1951)

A.4.3 Grandes fondations

Fondation	Public	Spécificité
Fondation Ensemble	DI	~250 personnes, 5 structures
Fondation Aigues-Vertes	DI	~120-137 résidents, anthroposophique, Bernex
EPI	Polyhandicap, DI	> 2 000 personnes/an, > 40 lieux
Fondation Clair Bois	Polyhandicap	Enfants, adolescents, adultes
Fondation Foyer-Handicap	Handicap physique	Adultes

A.5 Projet emblématique : Bureaux

i Habitat coopératif inclusif

- **Lieu** : Chêne-Bougeries
- **Partenariat** : Codha + Fondation Ensemble
- **Calendrier** : chantier 2018, emménagement mars 2021
- **Composition** : 19 logements dont 3 réservés à Ensemble (~12 résidents avec DI)
- **Reconnaissance** : 1 prix Coopératives Habitat Suisse, catégorie « partenariat »

A.6 Écosystème de recherche HETS

Structure	Rôle
CERES	Centre de recherches sociales, 5 axes, pôle Handicap
Réseau Autonomie-Handicap-Dépendance HETS-GE	Animé par Catherine Lenzi
GIS Hybrida-IS	Réseau international (2016), 23 équipes, ~90 chercheur · es

B Glossaire

- Activité réelle / réel de l'activité** Concept central de la clinique de l'activité (Clot, 2008). Désigne l'activité telle qu'elle se déploie effectivement en situation — incluant ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, ce qui aurait pu être fait, et ce qui est empêché.
- Agentivité (agency)** Capacité à agir comme l'agent causal de sa propre vie. Mobilisée par Wehmeyer (1996) dans la *Causal Agency Theory* de l'autodétermination.
- Autodétermination** Concept opérationnalisé par Wehmeyer (1996) puis Ryan & Deci (2017). Capacité d'une personne à agir comme agent causal de sa vie, en s'appuyant sur trois besoins fondamentaux : autonomie, compétence, appartenance.
- Autonomie discrétionnaire** Marge d'appréciation laissée aux *street-level bureaucrats* (Lipsky, 2010) dans la mise en œuvre des politiques publiques.
- Capabilité (capability)** Approche développée par Sen et Nussbaum (2006). Désigne **ce que la personne peut effectivement faire et être**, compte tenu de ses ressources et des supports environnementaux.
- CDPH** Convention relative aux droits des personnes handicapées (Organisation des Nations Unies, 2006). Traité international ONU, ratifié par la Suisse le 15 avril 2014.
- Care (éthique du)** Approche développée par Gilligan, Tronto (2009), Paperman & Laugier (2011). Pense la vulnérabilité comme condition humaine universelle et redistribue la responsabilité du care.
- Cash-for-care** Politiques qui transfèrent l'argent du soin à la personne plutôt qu'à l'institution. La contribution d'assistance AI suisse en est un exemple.
- Contribution d'assistance AI** Prestation introduite le 1 janvier 2012 (6 révision LAI). Permet à la personne d'engager elle-même ses assistant·es. ~2 600 bénéficiaires en 2019, 81 % de satisfaction (OFAS, 2020).
- Désinstitutionnalisation** Processus de transformation visant à sortir des grandes institutions au profit de services de proximité. Cadrée par l'art. 19 CDPH.
- Dignité du risque** Concept de Perske (1972). Les personnes ayant une déficience intellectuelle ont droit à prendre des risques ordinaires.
- Disability (vs Impairment)** Distinction centrale du modèle social britannique (Oliver, 1990; Union of the Physically Impaired Against Segregation, 1976). L'*impairment* est la déficience corporelle ; la *disability* est le handicap social produit par les barrières.
- Droits vulnérables** Concept de Revillard (2020). Droits sociaux dont l'existence formelle ne garantit pas l'effectivité.
- Genre professionnel** Concept de la clinique de l'activité (Clot, 1999). Manières de faire propres à un métier, déposées dans le collectif.
- Habitudes de vie** Concept central du MDH-PPH (Fougeyrollas, 2010). Activités courantes ou rôles sociaux valorisés. Une situation de handicap survient quand leur réalisation est compromise.
- IASIDD** *International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities*. Position officielle : Mansell & Beadle-Brown (2010).
- Inclusion (vs Intégration)** Distinction conceptuelle (Ebersold, 2017; Plaisance, 2009). L'**intégration** suppose que la personne s'adapte au cadre ordinaire ; l'**inclusion** suppose que le cadre se transforme.
- MDH-PPH** Modèle de Développement Humain – Processus de Production du Handicap (Fougeyrollas, 2010). Modèle francophone québécois.
- Pair-aidance** Pratique d'accompagnement reposant sur le partage d'expérience entre personnes ayant traversé une situation similaire (Jouet et al., 2010; Souesme, 2024).
- Pouvoir d'agir** Concept de Clot (2008). Possibilité effective d'agir sur son milieu et sur soi-même.
- Praticien réflexif** Concept de Schön (1994). Désigne le professionnel qui mobilise une *reflection-in-action*.

Réadaptation Paradigme moderne analysé par Stiker (2013). « *Réadapter, c'est ramener à la norme, à l'identique, et désigner par là même comme différent.* »

Savoir expérientiel Savoir développé par les personnes concernées au fil de l'expérience d'une maladie, d'un handicap ou d'une situation (Jouet et al., 2010).

Situation de handicap Concept central du MDH-PPH (Fougeyrollas, 2010). Le handicap n'est pas un état mais une situation variable selon l'interaction personne-environnement.

Street-level bureaucracy Concept de Lipsky (2010). Les agents de terrain qui appliquent les politiques au contact des usagers sont les véritables *policy makers*.

Stigmaté Concept de Goffman (1975). Attribut socialement disqualifiant.

Supported decision-making « Soutien à la décision ». Paradigme alternatif à la substitution de décision, porté par l'art. 12 CDPH.

Travail émotionnel Concept de Hochschild (1983). Production d'émotions appropriées au rôle attendu.

Transinstitutionnalisation Effet pervers de la désinstitutionnalisation : déplacement vers d'autres formes de ségrégation.

Valorisation des Rôles Sociaux (VRS / SRV) Concept de Wolfensberger. Reformulation du principe de normalisation centrée sur l'accès des personnes dévalorisées à des rôles sociaux valorisés.

Validisme (ableism) Système d'oppression analysé par les *disability studies*. Naturalisation des capacités corporelles et cognitives des personnes valides comme norme.

Références

- Brasseur, P., & Rodriguez, J. (2019). Les handicapés témoins, les valides experts. La division sociale du travail dans des dispositifs participatifs sur la sexualité des personnes handicapées. *Participations*, 22(3), 139-158.
- Charlton, J. I. (1998). *Nothing About Us Without Us. Disability Oppression and Empowerment*. Berkeley: University of California Press.
- Clot, Y. (1999). *La fonction psychologique du travail*. Paris: PUF.
- Clot, Y. (2008). *Travail et pouvoir d'agir*. Paris: PUF.
- Comité ONU CDPH. (2022). Observations finales concernant le rapport initial de la Suisse.
- Dubois, V. (2010). *La vie au guichet. Administrer la misère* (3e éd.). Paris: Économica.
- Ebersold, S. (2017). *L'éducation inclusive. Privilège ou droit ?* Grenoble: PUG.
- Fougeyrollas, P. (2010). *La funambule, le fil et la toile. Modèles conceptuels appliqués au handicap*. Québec: Presses de l'Université Laval.
- Glendinning, C. (2008). Increasing choice and control for older and disabled people: a critical review of new developments in England. *Social Policy & Administration*, 42(5), 451-469.
- Goffman, E. (1975). *Stigmaté. Les usages sociaux des handicaps*. Paris: Minuit. (Original 1963).
- Hochschild, A. R. (1983). *The Managed Heart. Commercialization of Human Feeling*. Berkeley: University of California Press.
- Jouet, E., Flora, L., & Las Vergnas, O. (2010). Construction et reconnaissance des savoirs expérientiels des patients. *Pratiques de formation – Analyses*, 58-59.
- Le Bihan, B., Da Roit, B., & Sopadzhian, A. (2019). The turn to optional familism through the market: Long-term care, cash-for-care, and caregiving policies in Europe. *Social Policy & Administration*, 53(4), 579-595.
- Lenzi, C., & Moine, A. (Éds). (2025). *Des pas de côté dans le travail social. Le métier dans toutes ses marges*. Nîmes: Champ social.
- Lipsky, M. (2010). *Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services* (30th anniv.). New York: Russell Sage Foundation. (Original 1980).
- Mansell, J., & Beadle-Brown, J. (2010). Deinstitutionalisation and community living: position statement of the Comparative Policy and Practice Special Interest Research Group of IASSIDD. *Journal of Intellectual Disability Research*, 54(2), 104-112.
- Masse, M., Petitpierre, G., Delessert, Y., Jacquemettaz, M., & Wolf, J.-P. (2018). *Accessibilité et participation sociale. Quelles avancées, quelles résistances ?* Genève: Éditions ies.
- Nussbaum, M. (2006). *Frontiers of Justice. Disability, Nationality, Species Membership*. Cambridge, MA: Belknap/Harvard.
- OFAS. (2020). Évaluation finale de la contribution d'assistance AI. Berne.
- Oliver, M. (1990). *The Politics of Disablement*. Basingstoke: Macmillan.
- Organisation des Nations Unies. (2006). Convention relative aux droits des personnes handicapées. New York.
- Paperman, P., & Laugier, S. (Éds). (2011). *Le souci des autres. Éthique et politique du care*. Paris: Éditions de l'EHESS. (Original 2006).
- Perske, R. (1972). The dignity of risk and the mentally retarded. *Mental Retardation*, 10(1), 24-27.
- Plaisance, É. (2009). *Autrement capables*. Paris: Autrement.
- Revillard, A. (2020). *Des droits vulnérables. Handicap, action publique et changement social*. Paris: Presses de Sciences Po.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). *Self-Determination Theory. Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness*. New York: Guilford.

- Schön, D. A. (1994). *Le praticien réflexif. À la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel*. Montréal: Éditions Logiques. (Original 1983).
- Souesme, C. (2024). Des pairs pour faciliter l'habitat autonome. *REISO*.
- Stiker, H.-J. (2013). *Corps infirmes et sociétés. Essais d'anthropologie historique* (3e éd.). Paris: Dunod. (Original 1982).
- Tronto, J. (2009). *Un monde vulnérable. Pour une politique du care*. Paris: La Découverte.
- Union of the Physically Impaired Against Segregation. (1976). *Fundamental Principles of Disability*. London.
- Ville, I., Fillion, E., & Ravaut, J.-F. (2020). *Introduction à la sociologie du handicap. Histoire, politiques et expérience* (2e éd.). Louvain-la-Neuve: De Boeck.
- Wehmeyer, M. (1996). Self-determination as an educational outcome. Dans D. J. Sands & M. L. Wehmeyer (Éds), *Self-determination across the life span* (pp. 17-36). Baltimore: Brookes.